

✓ 추나실습 써머리 가이드

- 중간(30%, 과제)+기말(30%)+출석(20%)+발표(10%, 기말 구두 시험)+실습태도(10%)
- 검은색: ppt 내용 / **붉고 빨간색 글씨: 강조** / 초록색: 교수님 설명
- (실습 중 첨언): 수업시간에 교수님에게 저희 조가 피드백 받은 내용입니다. 다른 피드백 받은 내용이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.

4장 경추부 추나치료

경추 신연기법

양와위 수건이용 경추 신연기법

- 과소전만: C4~C5에 걸고 위로 올려 경추 만곡을 확보한 뒤 45°정도로 뒤로 당기기
- 과전만: 후두골 기저부에 수건을 걸고 15°정도로 뒤로 당기기

1) 적응증

- 경추에 대한 일반적인 신연기법
- 과전만(Hyperlordosis): 수건의 각도를 좀더 예각으로 한다.
- 경추증(cervical spondylosis)
- 경추추간판 탈출증: 탈출된 Level 이상의 척추를 견인한다.
- 흉곽출구 증후군
→ 먼저 과소전만인지 과전만인지 평가가 중요. 누워있는 자세에서는 중력의 영향을 받아 전만이 풀리지만, 이것을 감안하더라도 약간의 전만이 존재하는 것이 정상

2) 치료절차

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 환자의 두부 위쪽 면에 빗장자세
- 주동수와 보조수의 구분 없이 환자의 목에서 가깝게 수건을 양손으로 균등하게 잡는다.
- 과소전만인지 과전만인지 구분
→ 목을 촉진했을 때 가장 움푹 들어가는 부분이 C4정도라고 볼 수 있다. 이때 전체적인 만곡을 살펴보면 각자 과소전만인지 과전만인지 파악해야하는데, 이 부분은 경험에 의한 것이다. (우리는 건강해서 크게 티가 안남)

3) 과소전만인 경우

→ 누워있을 때 목이 일자거나, 아래로 내려간 경우

- 접촉점: 경추 4-5번의 후면
- 교정의 방향: 약 80°정도로 수건을 후방에서 전방으로 당겨서 경추의 만곡을 확보한 다음 약 45°정도로 족방에서 두방으로 신연한다.
- 시술방법: 대부분의 환자가 생활습관이나 자세로 인하여 과소전만이 발생하며 이 경우에는 견갑대, 흉부, 요부까지 근육이 긴장되어 있는 경우가 많다. 시술방법은 수건을 환자의 경추의 4-5번의 후면에 걸고 목과 밀착된 부위의 수건을 양손으로 균등하게 잡고 손목의 힘을 이용하여 후방에서 전방으로 몇번 들어 올리듯 당겨서 경추의 만곡을 확보한 다음 팔을 쭉 펴고 체중을 이용하여 약 30-60초 간 부드럽게 족방에서 두방으로, 후방에서 전방으로 신연한다. 신연을 하고 있는 도중 환자에게 신연으로 인한 통증, 어지러움 등을 확인하고 혹시 불편을 호소하면 조금 더 부드럽게 신연하든지 중지한다.

→ C4~C5 정도에서 수직에 가깝게 신전을 해서 전만을 만든 다음 족방에서 두방으로 신연



4) 과전만인 경우

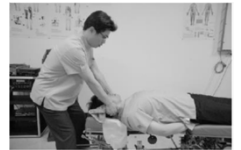
→ 누워있을 때 중부 경추 부분이 뺨쪽하거나, 고개를 끄덕이는 자세를 힘들어하는 경우

- 접촉점: 후두골 기저부
- 교정의 방향: 약 15°정도로 족방에서 두방으로 신연한다.
- 정상적인 경추 각도인 35°정도를 넘어서거나 경추관절의 과가동성이 증가되어 있는 경우에 적용한다. 특히 전형적인 경추는 과소전만인데 비하여 상부경추만 과전만인 경우가 많기 때문에 잘 확인하여 사용한다.
- 시술방법: 수건을 환자의 후두골기저부에 걸고 후두부와 밀착된 부위의 수건을 양손으로 균등하게 잡고 아주 약간의 힘을 주어 족방에서 두방으로 신연을 한다. 이 상태에서 환자에게 턱을 당기게 하고 의사는 수건을 잡은 손을 유지한 채로 환자에게 머리를 전방에서 후방으로 병진시키듯 약 5초간 가볍게 수건에 힘을 주어 등척성 수축을 하게 한다. 3-5회를 반복한다.

→ 후두골에 걸어서 족방에서 두방으로 수평적인 힘을 줌 = 전만을 줄임

→ (첨언 1) 시행할 때 환자에게 "턱을 아래로 내리세요"라고 말하며 진행하면 더 수월하게 할 수 있음

→ (첨언 2) 뒤로 신연할 때 체중을 이용해서 뒤로 당기며, 머리가 위로 최대한 들리지 않게 했음



양와위 경추 신연기법 → 앞선 방법과 동일, 수건이나 손이나 차이

- **과소전만**: C4~C5를 잡고 위로 올려 경추 만곡을 확보한 뒤 45°정도로 뒤로 당기기
- **과전만**: 후두골 기저부를 손으로 잡고 15°정도로 뒤로 당기기

1) 적응증

- 경추에 대한 일반적인 신연기법
- 과전만(Hyperlordosis)
- 과소전만(Hypolordosis)
- 경추증(cervical spondylosis)
- 경추추간판 탈출증: 탈출된 Level 이상의 척추를 견인한다.

2) 치료절차

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 환자의 두부 위쪽 면에 빗장자세
- 주동수와 보조수의 구분 없이 양손을 균등하게 사용한다.
- 시술방법: 먼저 환자의 상태가 과소전만인지 과전만인지 또는 과소전만일지라도 전형적인 경추에서만 과소전만이고 상부경추는 과전만되어 있는 경우가 많으므로 진단 후 경우에 맞게 시행한다.

3) 과소전만인 경우

- 접촉점: 경추 4-5번의 후면
- 교정의 방향: 먼저 후방에서 전방으로 경추의 만곡을 확보하고 나서 약 45°정도로 측방에서 두방으로, 신전방향으로 신연한다.
- 시술방법: 양손을 균등하게 사용하는데 양손의 식지를 이용하여 제4경추의 후면에 접촉한 후 나머지 손가락은 붙여서 식지에 힘을 모아준다. 먼저 손목을 이용하여 후방에서 전방으로 들어올려 경추의 만곡을 확보한 다음 측방에서 두방으로 약 45°정도로 신전방향으로 신연한다. 의사는 팔꿈치를 몸에 밀착하여 팔의 힘이 아닌 체중을 이용하여 부드럽게 신연한다.



4) 과전만인 경우

- 접촉점: 후두골 기저부
- 교정의 방향: 약 15°정도로 측방에서 두방으로, 굴곡 방향으로 신연한다.
- 시술방법: 양손을 균등하게 사용하는데 의사는 손바닥으로 측두와 관골부의 후면을 잡고 식지는 후두골의 기저부에 접촉한 후 나머지 손가락을 이용하여 후두골을 지탱한다. 식지의 힘을 이용하여 머리를 측방에서 두방으로 15° 정도로 약하게 신연을 한다. 이 상태에서 환자에게 턱을 당기게 하고 의사는 후두부를 견인하는 힘을 유지한 채로 환자에게 머리를 전방에서 후방으로 병진시키듯 약 5초간 가볍게 의사의 손에 힘을 주어 등척성 수축을 유도한다. 3-5회 반복한다.

→ (첨연) 기법을 시행할 때 환자의 귀를 덮지 않도록 조심



복와위 경추 신연기법

- 방법: 환자가 **오른쪽으로 고개를 돌렸으면 왼손의 엄지와 검지를 L자가 되게 손바닥을 피고, 왼쪽 견갑골 내측 상연을 강하게 아래로 눌러서 고정**한 뒤, **오른손으로 고개가 측굴 되게** 눌러준다.

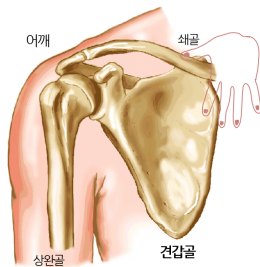
1) 적응증

- 경추에 대한 일반적인 신연기법
- 落枕
- 경추증(cervical spondylosis)
- 경추추간판 탈출증 등

2) 치료절차

- 환자의 자세: 복와위
- 의사의 자세: 환자의 두부 위쪽 면에 빗장자세
- 주동수: 환자의 고개를 가볍게 돌려 귀를 엄지와 다른 손가락 사이에 넣고 관골부를 손바닥으로 지지한다.
- 보조수: 고개 돌린 쪽의 견갑 내측상연을 무지식지간으로 잡고 손바닥을 같이 사용하여 지지한다.
- 교정의 방향: 족방에서 두방으로, 고개를 돌린 쪽 반대편의 대각선 방향으로 신연한다.

3) 시술방법



- 시술을 하기 전에 환자의 어느 쪽이 더 불편한지를 알아내는게 필요하다. 방법은 환자의 머리를 어느 한 쪽으로 완전히 회전시킨 다음 보조수의 무지식지간으로 견갑골의 내측상연을 잡고 손바닥을 같이 사용하여 고정하고 주동수의 장근부로 측두부를 잡아 족방에서 두방으로 후방에서 전방으로 목을 약간 견인시키면서 신연시킨다.

- 반대쪽도 동일한 방법을 사용한다. 환자가 근육의 긴장이나 관절의 운동 제한 등이 있다면 어느 한쪽에 불편함을 많이 호소한다. 환자가 불편을 호소하는 쪽에 주로 신연기법을 사용하는데 먼저 보조수의 무지식지간으로 견갑골의 내측상연을 단단히 고정하고 주동수의 장근부로 측두부를 잡아 환자의 머리를 약간 회전시키고 상부 중부 하부경추의 각도를 증가시키며 대각선 방향으로 부드럽게 신연시킨다. 상부, 중부, 하부로 나누어서 약 5-10초간 유지한다.

→ 고개를 회전시킨 상태에서 대측 견갑골 내측 상연을 손바닥으로 그림처럼 고정된 뒤, 다른 손으로 귀가 덮이지 않게 머리를 누른다.

→ (첨언 1) 고개를 회전하고 살짝 굴곡 시킨 뒤, 반대쪽으로 측굴시켜서 견갑거근 라인과 척추 쪽 라인을 눌러준다는 느낌으로 당기기

→ (첨언 2) 베드의 헤드 부분을 살짝 내리거나, 환자의 머리를 베드 밖으로 나오게 한 뒤, 시술자의 무릎 위에 환자 머리를 두고 높이 조절을 할 수 있다.

용어 정리

[개념]

- 신전이 잘 안 된다 = 후관절이 서로 잘 안 가까워진다. = 후관절이 닫히지 않는다고 표현
- 굴곡이 안 된다 = 후관절이 서로 잘 안 멀어진다. = 후관절이 열리지 않는다고 표현
- 굴곡 = Flexion / 신전 = Extension / 측굴 = Side bending / 회전 = Rotation

[과정]

- 굴곡변위가 존재한다 = 신전이 잘 안 된다.
- 몸이 좌측굴 좌회전 된 상태이다.(좌측굴 좌회전 변위) = 우측굴 우회전하기 힘들다.

[결과]

- 만약에 신전 우측굴 우회전이 안되는 경우 (우측의 후관절이 잘 닫히지 않는 상태)
= 굴곡 좌측굴 좌회전 변위가 있다. = FRS(L) 변위
- 반대로 굴곡 좌측굴 좌회전이 안되는 경우 (좌측의 후관절이 잘 열리지 않는 상태)
= 신전 우측굴 우회전 변위가 있다. = ERS(R) 변위

경추 교정기법

양와위 경추 JS 신연 교정기법 → 경추는 항상 측굴과 회전이 같은 방향으로만 운동함

- 1단계(측굴): articular pillar 부분을 밀어주기
- 2단계(회전): 횡돌기를 들어올리기
- 3단계(신전): 경추 신연기법을 하부, 중부, 상부 경추에 각각 시행해보기

1) 적응증

- 경추 가동성 제한 및 가벼운 회전 변위

2) 치료절차

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 환자의 머리위에서 족방을 향하여 앉는다.
- 주동수와 보조수의 구분 없이 1단계는 양측 장근부로 측두골을 받쳐주고 양측 중지단으로 각 경추의 관절돌기에 접촉한다. 2, 3단계는 양측 장근부로 측두골에 접촉하고 양측 식지로 관절돌기에 접촉한다.
- 교정의 방향: 1단계는 좌우로 교대로 밀어주고, 2단계는 좌우 교대로 한분절씩 거상하고, 3단계는 관절돌기후면을 들면서 양측을 두방으로 동시에 신연한다.

3) 시술방법

① 1단계(측굴)



- 1단계는 장근부로 환자 측두부를 받쳐주고, 의사의 양측 중지단으로 환자의 관절돌기면을 좌우로 열어준다는 느낌으로 교대로 밀어준다.
→ 횡돌기와 극돌기의 중간 쯤에서 articular pillar를 찾을 수 있다. 이 부위를 손가락으로 누르는데, 이때 손가락은 DIP, PIP가 굴곡된 상태로 articular pillar에 고정하고, 팔을 이용해서 밀어준다. 이것을 좌우 모두 시행하며 C1~C7까지 다 확인하고 어느 부위에 문제가 있는지 확인
→ 잘하는 사람은 양손을 모두 대고 동시에 양쪽을 할 수 있고, 미숙한 경우 보조수로 머리를 고정된 상태에서 주동수 쪽으로 머리를 살짝 측굴할 수도 있다.
(측굴은 선생님들이 시연하는 것을 보고 적은거라서 확실하지 않습니다. 고정만 확실!)

② 2단계(회전)



- 2단계는 장근부를 측두부에 접촉하고 의사의 식지를 이용하여 환자의 관절돌기면을 좌우 교대로 돌려준다는 느낌으로 한 분절씩 거상한다.
→ 식지를 횡돌기에 대고 관절을 직접 들어올리는 것이다.
→ 직접 접촉이 안 된 상태에서 들면 살만 들어올릴 가능성이 높다. 주동수의 식지를 MCP, PIP 부위를 횡돌기에 대고, 보조수로 대측 mandible을 고정된 상태에서 경추 하나씩 들어올려서 회전을 확인한다.

③ 3단계(신전)



- 3단계는 의사의 식지를 이용하여 제 6경추부터 제 2경추까지 환자의 관절돌기 후면을 들어서 관절돌기까지 가볍게 양측을 동시에 당겨주는 느낌으로 신연한다.
 - 앞서 경추 신연기법 중 과소전만을 한 것처럼 시행하는데, 이때 3단계의 경우 경추 하나하나를 다 하지는 않고, 하부경추, 중부경추, 상부경추를 각각 시행하여 이상한 부분이 있는지 확인한다.